

Examen: Unidad IV
Líquidos y Fenómenos de Transporte
Física para Ciencias de la Salud (005-1713) – Bioanálisis

Instrucciones: Este examen evalúa la comprensión profunda y el análisis físico aplicado a fenómenos biológicos y clínicos. No basta con escribir fórmulas matemáticas; debe argumentar, analizar y justificar cada una de sus respuestas basándose en los principios físicos estudiados.

1. Termorregulación y Eficiencia de la Sudoración:

Dos pacientes, A y B, se encuentran en un ambiente cálido realizando la misma actividad física y necesitan disipar la misma cantidad total de calor para mantener su temperatura corporal constante. El paciente A tiene un mecanismo de sudoración eficiente donde casi toda el agua segregada por las glándulas se *evapora* sobre la piel. Por el contrario, el paciente B presenta una alteración en la que gran parte de su sudor gotea rápidamente y cae de la piel en forma líquida antes de poder evaporarse.

- Desde el punto de vista del *calor latente de vaporización*, ¿qué paciente necesitará secretar un mayor volumen total de sudor para lograr disipar la misma cantidad de calor? Justifique su respuesta detallando el proceso de transferencia de energía térmica.
- Si de repente la humedad relativa del ambiente aumenta drásticamente (acercándose al 100 %), ¿cómo afectará esto físicamente a la capacidad de termorregulación de ambos pacientes y qué peligro clínico (ej. golpe de calor) se puede deducir?
- Calcule el calor total disipado por el paciente A si logra evaporar 150 g de sudor a 37°C (donde el calor latente es $L_v = 2,42 \times 10^6 \text{ J/kg}$). Exprese su resultado en Joules y kilocalorías (1 kcal = 4186 J).

2. Mecánica Respiratoria y Síndrome de Dificultad Respiratoria:

Un neonato prematuro nace con una deficiencia grave de *surfactante pulmonar*. En una radiografía y evaluación clínica se observa un patrón característico: los alvéolos más pequeños tienden a colapsar por completo (atelectasia), mientras que el aire se redistribuye hacia los alvéolos más grandes, los cuales se hiperinsuflan.

- Utilizando la *Ley de Laplace* para la diferencia de presiones en burbujas esféricas, demuestre físicamente por qué ocurre este flujo anómalo de aire desde los alvéolos pequeños hacia los grandes cuando la tensión superficial es constante (ausencia de surfactante).
- Explique cuál es el papel fisiológico y físico del surfactante pulmonar natural para evitar este colapso, detallando cómo modifica la tensión superficial en función del radio del alvéolo.
- Calcule la presión interna ΔP (en Pascales) requerida para mantener abierto un alvéolo pequeño de radio $r = 5,0 \times 10^{-5} \text{ m}$ si carece de surfactante y presenta una tensión superficial similar al agua ($\gamma = 0,070 \text{ N/m}$).

3. Optimización en Hemodiálisis (Primera Ley de Fick):

En el desarrollo de un nuevo dializador (riñón artificial) para limpiar la sangre de urea, un equipo de ingenieros biomédicos propone cambiar la membrana semipermeable. Deciden utilizar un nuevo material que permite reducir el *espesor* de la membrana a la *mitad* ($\Delta x_{\text{nuevo}} = \frac{1}{2} \Delta x_{\text{original}}$). Sin embargo, debido a limitaciones geométricas del cartucho, la *superficie total de contacto* de esta nueva membrana es un **30 % menor** que la del modelo anterior ($A_{\text{nuevo}} = 0,70 A_{\text{original}}$).

- Basándose estrictamente en la *Primera Ley de Fick*, determine matemáticamente si la tasa de transporte de masa de urea ($\frac{\Delta m}{\Delta t}$) será mayor, menor o igual con el nuevo diseño en comparación con el original (asumiendo que el coeficiente de difusión y el gradiente de concentraciones se mantienen constantes).
- Aparte del análisis matemático, discuta brevemente qué riesgo mecánico o estructural podría implicar en la práctica clínica hacer la membrana de diálisis cada vez más delgada.
- Si la membrana original tiene un área $A = 1,5 \text{ m}^2$, espesor $\Delta x = 2,0 \times 10^{-5} \text{ m}$, el gradiente de concentración de urea es $\Delta C = 2,0 \times 10^{-3} \text{ kg/m}^3$ y su coeficiente de difusión es $D = 1,2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$, calcule la tasa original de transporte de masa ($\frac{\Delta m}{\Delta t}$) en kg/s.

4. Errores de Infusión Intravenosa y Ósmosis:

Durante una guardia hospitalaria, por un error de etiquetado, a un paciente deshidratado se le administra una infusión rápida e intravenosa de *agua destilada pura* en lugar de la solución salina isotónica prescrita (0,9 % NaCl).

- Utilizando el concepto de *presión osmótica* y analizando las osmolaridades intra y extracelulares, describa el flujo neto de solvente a través de la membrana de los eritrocitos. ¿Qué fenómeno fisiopatológico ocurrirá con los glóbulos rojos del paciente como consecuencia directa?
- Si el equipo médico detecta el error minutos después e intenta compensarlo administrando inmediatamente una solución fuertemente *hipertónica* (ej. NaCl al 5 %), ¿cómo reaccionarán los eritrocitos que aún sobreviven en el torrente sanguíneo ante este cambio drástico? Justifique físicamente.
- Calcule la presión osmótica teórica (en atmósferas) de la solución salina isotónica prescrita (0,9 % NaCl), sabiendo que equivale a una concentración de 0,154 mol/L, con un factor de van 't Hoff $i = 2$ a la temperatura corporal de 37°C (310 K). Utilice $R = 0,0821 \text{ L}\cdot\text{atm}/(\text{mol}\cdot\text{K})$.

5. Capilaridad y Toma de Muestras Sanguíneas:

En un laboratorio clínico, se utilizan tubos capilares de vidrio para la extracción de micromuestras de sangre. Un lote defectuoso de tubos ha sido recubierto accidentalmente en su interior con un material hidrofóbico, lo que altera significativamente el ángulo de contacto entre la sangre y la pared interna del tubo (el ángulo pasa a ser $\theta > 90^\circ$).

- Basándose en la *Ley de Jurin*, analice qué ocurrirá con la columna de sangre al poner en contacto el extremo del tubo con la gota de sangre. ¿Ascenderá o descenderá respecto al nivel de la gota original? Justifique su respuesta prestando atención a las fuerzas de cohesión y adhesión.
- Si en lugar del lote defectuoso, se utiliza un tubo capilar de vidrio perfectamente limpio y mojado ($\theta \approx 0^\circ$), pero con un *diámetro interno mucho menor* (microcapilar), ¿cómo afectaría esto a la altura alcanzada por la sangre y por qué representa una ventaja física para obtener la muestra de forma eficiente?
- Calcule la altura máxima h que ascenderá la sangre en un tubo capilar de vidrio limpio ($\theta = 0^\circ$) cuyo radio interno es $r = 2,0 \times 10^{-4} \text{ m}$. (Datos de la sangre: $\gamma = 0,058 \text{ N/m}$, $\rho = 1060 \text{ kg/m}^3$ y $g = 9,8 \text{ m/s}^2$).

① ejercicio numero #01 termoregulacion y eficiencia de la sudoracion

R =

a) Justificacion del volumen de sudor

El paciente B necesitara secretar un mayor volumen total. El calor se disipa cuando el agua cambia de fase liquida a gaseosa. Este proceso absorbe el calor latente de vaporizacion ($Q = m \cdot L_v$) directamente de la piel. Como el sudor del paciente B gotea, se desprende en estado liquido sin evaporarse, perdiendo la oportunidad de enfriar el cuerpo. Debe sudar mas para compensar esa perdida.

b) Efecto en la humedad 100% y peligro clinico

La evaporacion del sudor se reduce a cero. El gradiente de presion de vapor entre la piel y el ambiente desaparece. fisicamente, el sudor no puede evaporarse. clinicamente el cuerpo pierde un principal via de enfriamiento, acumulando calor interno rapidamente, lo que puede provocar un golpe de calor (hipertemia severa y falla multiorganica).

c) calculo del calor total disipado por el paciente A

$$\text{Datos: } m = 150 \text{ g} = 0,150 \text{ Kg}; L_v = 4,42 \times 10^6 \text{ J/Kg}$$

en Joules

$$Q = m \cdot L_v = 0,150 \text{ Kg} \times 4,42 \times 10^6 \text{ J/Kg} = 6,63 \times 10^5$$

En Kilocalorías :

$$Q = \frac{363.000 \text{ J}}{4186 \text{ J/Kcal}} \approx 86,72 \text{ Kcal}$$

(2)

2 ejercicio : Mecánica Respiratoria y síndrome de Dificultad respiratoria.

a) demostración del flujo anómalo (Ley de Laplace):

La ley de Laplace para una esfera establece que la presión interna es $\Delta P = \frac{2\gamma}{r}$. Si la tensión superficial (γ) es constante por falta de surfactante, la presión es inversamente proporcional al radio ($\Delta P \propto \frac{1}{r}$). Por lo tanto, los alvéolos pequeños tienen mayor presión interna que los grandes. El aire se desplaza naturalmente de mayor a menor presión, fluyendo desde los alvéolos pequeños hacia los grandes, colapsando los primeros.

b) papel fisiológico de los surfactante : El surfactante reduce la tensión superficial de forma dinámica. Su concentración por unidad de área, aumenta cuando el alvéolo disminuye su tamaño. Esto disminuye γ a medida que disminuye r , estabilizando la relación $\frac{2\gamma}{r}$ para que la presión sea igual en alvéolos de distintos tamaños, evitando el colapso.

c) Cálculo de la presión interna (ΔP):

Datos : $r = 5,0 \times 10^{-5} \text{ m}$; $\gamma = 0,070 \text{ N/m}$

fórmula

$$\Delta P = \frac{2\gamma}{r} = \frac{2 \times 0,070 \text{ N/m}}{5,0 \times 10^{-5} \text{ m}} = 2800 \text{ Pa}$$

Ejercicio n° 3 = optimización en hemodialisis (primera ley de fick):

a) determinación matemática de la tasa de transporte: la primera ley de fick es

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = D \cdot A \cdot \frac{\Delta C}{\Delta x} \text{ sustituyendo los nuevos valores:}$$

$$(A_{\text{nuevo}} = 0,70, A \text{ y } \Delta x_{\text{nuevo}} = 0,50 \cdot \Delta x):$$

$$\left(\frac{\Delta m}{\Delta t} \right)_{\text{nuevo}} = D \cdot (0,70 \cdot A) \cdot \frac{\Delta C}{0,50 \cdot \Delta x} = \frac{0,70}{0,50} \cdot \left(D \cdot A \cdot \frac{\Delta C}{\Delta x} \right)$$

la tasa de transporte será un 40% mayor (factor de 1,4), por lo que el diseño es más eficiente.

b) Puntos mecánicos en la práctica clínica:

Reducir excesivamente el grosor de la membrana compromete severamente su integridad estructural, haciéndola susceptible a roturas o desgarros bajo el régimen de presiones de bombeo del circuito. Esto causaría contaminación recíproca entre la sangre y el líquido de dialisis o una pérdida hemática crítica.

c) Cálculo de la tasa original de transporte de masa

Datos:

$$A = 1.5 \text{ m}^2$$

$$\Delta x = 2,0 \times 10^{-5} \text{ m}$$

$$\Delta C = 2,0 \times 10^3 \text{ Kg/m}^3$$

$$D = 1.2 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$$

Cálculo

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = (1,2 \times 10^{-9}) \times 1,5 \times \left(\frac{2,0 \times 10^{-3}}{2,0 \times 10^{-5}} \right)$$

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = (1,8 \times 10^{-9}) \times 100 = 1,8 \times 10^{-7} \text{ Kg/s}$$

(4)

Ejercicio N° 4: Efectos de infusión intravenosa y osmosis

a) flujo neto de solvente y fenómeno fisiopatológico

Flujo neto: el agua destilada es una solución fuertemente hipotónica (osmolaridad cercana a cero) en comparación con el espacio intracelular de los eritrocitos ($\approx 300 \text{ mOsm/L}$). Por osmosis, el agua fluirá netamente desde el plasma (exterior) hacia el interior de los glóbulos rojos para intentar equilibrar las concentraciones.

Fenómeno fisiopatológico: la entrada masiva de agua provocará el hinchamiento celular (turgencia) hasta superar la resistencia elástica de la membrana citoplasmática, induciendo la hemólisis acuosa (ruptura de glóbulos rojos) y la consecuente liberación de hemoglobina al plasma.

b) reacción presión osmótica:

$$\Pi = 2 \times 0,154 \times 0,0821 \times 310 = 7,84 \text{ atm}$$



33M

AÑO

DÍA

MES

AÑO TAM

Ejercicio n° 5 Capilaridad y toma de muestras
rangueiras

Angulo $> 90^\circ$ (hidrofóbico): las fuerzas de cohesión son mayores que las de adhesión $\rightarrow$ la ranque descendida.

Microcapilar: Al achicar el radio, el líquido sube mucho mas (ley de Jurin). permite tomar muestras con solo un pinchazo, sin succiones.

Calculo de Altura

$$h = \frac{1.116 \times 10^{-5}}{r} \text{ metros}$$

(El resultado final exacto depende del radio r del tubo).